Пролапс тазовых органов – разобраться в терминологии.

Кажется, понятие «дефицит» из нашей жизни исчезло навсегда. Сейчас в избытке всё: товары, услуги, информация. Однако, несмотря на множество образовательных программ на ТВ, большое количество медицинских статей в прессе и в интернет, многие девушки и дамы, столкнувшись с симптомами гинекологических заболеваний, впадают в панику. А все потому, что изжить стереотипные представления о недугах трудно. Обратимся к заблуждениям, которые связаны с пролапсом тазовых органов. Развеем их.

Разобраться в терминологии

Под загадочным термином «пролапс» понимается нарушение положения тазовых органов (матки, мочевого пузыря, прямой кишки), в частности изменение анатомии влагалища, его опущение, выпадение, смещение матки ниже физиологического уровня, влекущее за собой нарушения в работе мочевой системы, кишечника.

Естественное положение органов определяется тазовыми мышцами, именно они обеспечивают стабильное положение матки при возрастании внутрибрюшного давления, физической нагрузке. Они же задействуются во время беременности и родов. Именно последний фактор, ведет к сильному растяжению мышц, что наиболее часто и становится основной причиной пролапса. Наряду с ним, могут оказывать влияние:

- наследственная предрасположенность,
- возрастная атрофия мышц,
- легочные заболевания и курение – хронический кашель,
- нарушения в работе желудочно-кишечного тракта – хронические запоры,
- стрессы, неврологические проблемы,
- хирургические вмешательств,
- подъем тяжестей и чрезмерно интенсивные занятия спортом.

Разнообразие провоцирующих патологию моментов определяет и высокую частоту диагностики пролапса. На долю патологии приходится почти 40% от всех гинекологических заболеваний.



Опущение и пролапс матки

Не факт

Мнение: «Мне рассказывали, что пролапс бывает только у пожилых женщин, а мне еще нет и 35 лет. Поговорим о проблеме, когда я выйду на пенсию».

Факт

Частое заблуждение. По данным статистики, примерно 10%- 12% пациенток гинекологов с опущением тазовых органов моложе 30 лет. Причинами могут стать врожденные анатомические особенности, определяющие недостаточность мышц тазового дна, истощение структур вследствие беременностей, а также использование во время родов вспомогательных технологий – щипцов, ведущее в том числе и к разрыву тканей. Стремление к идеальной фигуре тоже может вызвать пролапс из-за резкой потери массы тела и чрезмерных физических нагрузок.

Не факт

Мнение: «Всегда думала, что пролапс равно недержание мочи».

Факт

Часто пролапс диагностируется при обращении женщины к врачу по поводу снижения качества интимной жизни, причем его отмечает и партнер. Других симптомов на первых этапах может и не быть. При выраженной патологии возникает болевой синдром, чувство давления и тяжести, ощущение инородного тела в половых органах. Частые позывы к мочеиспусканию одно из проявлений пролапса, свидетельствующее уже и об ослаблении связочного аппарата мочевого пузыря. Однако, это проявление заболевания часто становится самым тягостным, из-за постоянной, навязчивой необходимости посетить туалет, а также из-за страха опорожнения

мочевого пузыря во время полового контакта. Кроме того, может беспокоить недержание газов, запоры, трудности с дефекацией (иногда требуется вправление стенок влагалища для того, чтобы очистить кишечник).

Не факт

Мнение: «Зачем тратить время и деньги на обследование, когда и так все понятно. Выпадение половых органов нельзя не заметить»

Факт

Аппаратная визуализация состояния тазового дна позволяет наиболее точно оценить характер и выраженность патологического процесса. Для чего используют ультразвуковую диагностику, рентген. Процедуры безболезненные, и по сравнению с другими методами диагностики не очень дорогостоящие. При необходимости получить расширенную картину заболевания врач может также направить на МРТ. Без диагностики не может идти речи о качественном лечении.

Не факт

Мнение: «Пролапс – заболевание современное, раньше женщины такое состояние за болезнь не считали, и не лечили».

Факт

Уже в V веке до н.э. женщины использовали специальные приспособления для удержания матки внутри организма. Они получили название – влагалищные пессарии. Сейчас это силиконовые или пластиковые кольца, имеющие более 100 модификаций, назначаемые для устранения генитального пролапса дамам пожилого возраста. То есть тем, кому не показаны другие методы коррекции. Ограничение применения пессариев связано с частыми побочными явлениями: эрозиями, увеличением количества выделений, риском инфекционных заболеваний.

Не факт

Мнение: «Лучше жить с пролапсом, чем согласиться на хирургическую операцию. Да еще и риски рецидива высокие, зачем себя мучить»

Факт

Заболевание необходимо лечить, выпадение создает резервуары для проникновения и размножения болезнетворных микроорганизмов, что может быть даже опасно для жизни. Также из-за неполного опорожнения мочевого пузыря создаются предпосылки для цистита. Действительно хирургическое вмешательство считается основным методом устранения пролапса. При этом риск рецидива составляет – 30%. Есть повод для размышлений. Наиболее часто риски связаны с осложнениями – инфицированием тканей, непрочностью тканей организма пациентки, обусловленной патологией синтеза коллагена (белка необходимого для построения соединительной ткани, обеспечения ее прочности и плотности). Но, отказываться от лечения значит сознательно ухудшать качество жизни. Здесь на помощь приходят достижения современной медицины. В сложных случаях для предупреждения рецидивов могут применятся синтетические имплантаты, сетчатые протезы. На более ранних этапах развития показаны консервативные методы: общеоздоровительные (правильный распорядок дня, сбалансированное питание), массаж матки, специальная гимнастика, электростимуляция мышц таза. Также могут рекомендоваться современные малоинвазивные методы лечения с использованием лазерных

технологий, значительно снижающие риски инфицирования тканей во время вмешательства и в восстановительном периоде.

В ногу со временем

Применение лазера для лечения пролапса и недержания мочи может помочь максимально быстро вернуться к привычному ритму жизни. Что важно для современных активных женщин подготовка к процедуре и само воздействием лазером на ткани малого таза проводится в амбулаторных условиях. Никакого стресса от пребывания в стенах больницы, возможность не выпадать из рабочего ритма.

Один из передовых аппаратов для проведения воздействия на ткани малого таза - CO2 лазер Eraser-C. В гинекологической практике используется сканерная технология подачи лазерного луча и специальная насадка для хирургических вмешательств.

Суть терапии заключается в прицельной обработке проблемных участков световым лучом, благодаря чему стимулируется естественная выработка столь необходимого коллагена, что способствует укреплению и утолщению мышечной ткани, отвечающей за поддержку органов малого таза. Из плюсов лазерного лечения:

- строго индивидуальный подход;
- отсутствие длительного периода подготовки и восстановления;
- устранение необходимости в анестезии;
- быстрота проведения вмешательства - манипуляции длятся не более получаса;
- отсутствие болевого синдрома.

Кстати, процедура лазерного омоложения, также выполняемая на аппарате CO2 лазер Eraser-C может стать своеобразной профилактикой пролапса тазовых органов. Она может быть показана женщинам спустя некоторое время после родов для восстановления эластичности стенок влагалища. Дополнительным бонусом может стать и улучшение качества интимной жизни. А также назначаться дамам, вступившим в период менопаузы. В этом случае стимуляция клеточной регенерации при помощи лазерного воздействия может снизить риски атрофии мышечной ткани тазовых органов.

В Москве процедуры лечения и профилактического воздействия лазером CO2 на ткани тазовых органов можно пройти в Клинике Современных Технологий (КСТ).